

Die 4 Demenzformen

Alzheimer, vaskulär, Lewy-Körper und frontotemporal – Ursache, Leitsymptome, Verlauf und Pflege-Schwerpunkte kompakt für das Pflegeexamen.



Bestehen ist planbar.

Alzheimer

Vaskulär

Lewy-Körper

Frontotemporal

Demenz vs. Delir

Kommunikation

4

Demenzformen

1

Vergleichstabelle

A4

druckfertig

INHALT

1

Alzheimer-Demenz

2

Vaskuläre Demenz

3

Lewy-Körper-Demenz

4

Frontotemporale Demenz

5

Vergleich auf einen Blick

6

Pflege & Kommunikation

⚠ Lernhilfe für Ausbildung und Prüfung, kein Ersatz für ärztliche Diagnostik oder Anordnung. Angaben können je nach Lehrbuch und Leitlinie leicht abweichen – maßgeblich ist der Standard deiner Einrichtung.

Die 4 Formen im Überblick

Pro Form: was im Gehirn passiert, woran du sie erkennst und welche Frage im Examen gern kommt.

1 • Alzheimer-Demenz

häufigste Form • ca. 60–70 %

Ursache	Neurodegeneration: Amyloid-Plaques und Tau-Fibrillen, Nervenzelluntergang – beginnt meist im Hippocampus/Schläfenlappen
Leitsymptome	Kurzzeitgedächtnis zuerst, Wortfindungsstörungen, Orientierungsstörungen (Zeit → Ort → Situation → Person), später Apraxie und Agnosie
Verlauf	Schleichend, langsam fortschreitend in drei Stadien (leicht • mittel • schwer) bis zum Verlust der Selbstständigkeit
Therapie	Leicht–mittel: Acetylcholinesterase-Hemmer (Donepezil, Rivastigmin, Galantamin) • mittel–schwer: Memantin • nicht heilbar
Pflege	Feste Tagesstruktur, Biografiearbeit, Orientierungshilfen (Uhr, Kalender, Namensschild), Validation

Examens-Falle: Das Langzeitgedächtnis bleibt lange erhalten – alte Erinnerungen sind eine Ressource für die Biografiearbeit.

2 • Vaskuläre Demenz

zweithäufigste Form

Ursache	Durchblutungsstörungen: viele kleine Infarkte („Mini-Schlaganfälle“) oder Schädigung der kleinen Hirngefäße
Risikofaktoren	Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Rauchen, Fettstoffwechselstörung, Vorhofflimmern
Leitsymptome	Verlangsamung, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörung, Gangstörung, Inkontinenz, Stimmungslabilität – Gedächtnis oft weniger betroffen
Verlauf	Stufenweise: plötzliche Verschlechterung nach jedem neuen Ereignis, dazwischen stabile Phasen
Pflege	RR- und BZ-Kontrolle, Sturzprophylaxe, Medikamenten-Adhärenz (Sekundärprophylaxe)

Examens-Falle: Neue neurologische Ausfälle (FAST: Gesicht, Arm, Sprache) sind ein Notfall – nicht als „Demenz“ abtun, sofort Arzt/Notruf.

3 • Lewy-Körper-Demenz

Halluzinationen + Parkinson

Ursache	Eiweißablagerungen (Lewy-Körperchen, α -Synuclein) in der Hirnrinde
Leitsymptome	Detailreiche visuelle Halluzinationen (Personen, Tiere), stark schwankende Wachheit und Tagesform, Parkinson-Symptome (Rigor, Bradykinese)
Weitere Zeichen	REM-Schlaf-Verhaltensstörung (Ausagieren von Träumen), häufige Stürze, Kreislaufschwankungen
Verlauf	Fortschreitend, mit großen Schwankungen von Tag zu Tag oder sogar Stunde zu Stunde
Pflege	Sturzprophylaxe, Halluzinationen nicht ausreden und nicht bestätigen – beruhigen, Licht und klare Umgebung

Examens-Falle: Überempfindlichkeit gegen Neuroleptika: klassische Neuroleptika (z. B. Haloperidol) können schwere, lebensbedrohliche Reaktionen auslösen – Beobachtungen sofort melden.

4 • Frontotemporale Demenz

Persönlichkeit vor Gedächtnis

Ursache	Abbau im Stirn- und Schläfenlappen (Frontal-/Temporallappen)
Beginn	Oft früher als andere Formen, häufig zwischen 50 und 60 Jahren
Leitsymptome	Frühe Wesensänderung: Enthemmung, Distanzlosigkeit, Taktlosigkeit, Apathie, Verlust von Empathie, verändertes Essverhalten (z. B. Heißhunger auf Süßes) · Sprachvariante: fortschreitende Sprachstörung
Gedächtnis	Bleibt zu Beginn oft noch intakt – deshalb wird die Erkrankung anfangs leicht als psychische Störung verkannt
Pflege	Klare Regeln und Routinen, Verhalten nicht persönlich nehmen, Angehörige entlasten und aufklären

Examens-Falle: Antidementiva wie Acetylcholinesterase-Hemmer sind bei der frontotemporalen Demenz nicht wirksam.

Screening-Tests: MMST (Mini-Mental-Status-Test, max. 30 Punkte), Uhrentest, DemTect – sie geben Hinweise, die Diagnose stellt der Arzt.

Vergleich auf einen Blick

Die Tabelle für die schnelle Wiederholung vor der Prüfung.

	Alzheimer	Vaskulär	Lewy-Körper	Frontotemporal
Erstes Zeichen	Vergesslichkeit	Verlangsamung	Halluzinationen, Schwankungen	Wesensänderung
Verlauf	schleichend	stufenweise	stark schwankend	schleichend
Gedächtnis früh	stark betroffen	eher erhalten	wechselnd	lange erhalten
Typisch	Plaques & Tau	Mini-Infarkte	Parkinson-Symptome	Enthemmung
Achtung	Biografie nutzen	Neue Ausfälle = Notfall	Neuroleptika!	oft jüngere Betroffene

Demenz oder Delir?

Die wichtigste Abgrenzung im Pflegealltag – ein Delir ist ein Notfall und oft behandelbar.

	Demenz	Delir
Beginn	schleichend über Monate	plötzlich, Stunden bis Tage
Bewusstsein	klar (bis spät)	getrübt, Aufmerksamkeit gestört
Tagesverlauf	relativ stabil	stark schwankend, oft nachts schlechter
Ursache	Hirnerkrankung	z. B. Infekt, Exsikkose, Medikamente, OP, Schmerz
Reversibel?	nein	meist ja – Ursache suchen!

Merke: Menschen mit Demenz haben ein deutlich erhöhtes Delir-Risiko. Plötzliche Verschlechterung immer melden – nicht als „Fortschreiten der Demenz“ deuten.

Pflege & Kommunikation

Gilt für alle Formen – Grundlage ist der DNQP-Expertenstandard „Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“.

SO SPRICHST DU

- Von vorne nähern, Blickkontakt, mit Namen ansprechen
- Kurze Sätze, eine Information pro Satz
- Geschlossene Fragen statt „Warum?“-Fragen
- Nicht korrigieren oder streiten – Gefühle aufgreifen (Validation)
- Ruhig bleiben, Zeit lassen, Gestik nutzen

DAS HilFT IM ALLTAG

- Feste Tagesstruktur und Bezugspflege
- Biografiearbeit: Gewohnheiten, Beruf, Rituale
- Orientierungshilfen: Uhr, Kalender, Bilder, Beschilderung
- Aktivierung nach Fähigkeiten, nicht nach Defiziten
- Herausforderndes Verhalten als Botschaft verstehen (Schmerz? Hunger? Angst?)



Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de